Machine Translated by Google

BMJ Open

Conocimientos, actitudes y prácticas hacia la prevención del cáncer de piel entre Adultos malasios: una encuesta transversal en línea

Ali Haider Mohammed,1,2 Bassam Abdul Rasool Hassan,2 Yen Jun Wong,1 Loh Hui Ying,1 Marcus Loh Boon Hong,1 Annabel Wong Sze Nee,1 Lo Siew Ying,1 Dinesh Sangarran Ramachandram,1 Hawar Sardar Hassan,3,4,5 Lee Jia Jia,1 Juman Dujaili, 6 Ali Blebil 6

Para citar: Mohammed AH, Hassan BAR, Wong YJ, et al. Conocimientos, actitudes y prácticas sobre la prevención del cáncer de piel entre adultos malasios: una encuesta transversal en línea. BMJ Open 2026;16:e103040. doi:10.1136/bmjopen-2025-103040

► El historial de prepublicación y el material complementario adicional para este artículo están disponibles en línea. Para ver estos archivos, visite la revista en línea (https://doi.org/10.1136/bmjopen-2025-103040).

Recibido el 1 de abril de 2025
Aceptado el 9 de febrero de 2026.

Check for updates

© Autor(es) (o su(s) empleador(es)) 2026. Se permite su reutilización bajo la licencia CC BY. Publicado por BMJ Group.

[1]Universidad Monash de Malasia, Bandar Sunway, Malasia
[2]Departamento de Farmacia, Colegio Universitario Al-Rafidain, Bagdad, Irak
[3]Departamento de Odontología, Universidad de Ciencias de Komar y Tecnología, Sulaymaniyah, Irak
[4]Investigación en tecnología nuclear Centro, Universiti Kebangsaan Malasia, Bangi, Malasia
[5]Departamento de Física Aplicada, Universidad Kebangsaan Malasia, Bangi, Malasia
[6]Facultad de Medicina de Swansea Universidad de Swansea, Reino Unido

Correspondencia a el doctor Ali Blebil; aqjblebil@swansea.ac.uk

ABSTRACTO

Objetivos : Evaluar los niveles de conocimiento, actitudes y prácticas (CAP) sobre la prevención del cáncer de piel entre los adultos malasios y examinar las diferencias en los CAP entre los distintos grupos sociodemográficos.

Diseñar una encuesta transversal en línea.

Contexto: Estudio comunitario realizado en Malasia mediante el reclutamiento a través de las redes sociales.

Participantes: Un total de 386 adultos mayores de 18 años residentes en Malasia. La mayoría de los participantes eran adultos jóvenes (86,3%), mujeres (55,4%) y de etnia china (65,5%).

Se excluyó a los profesionales sanitarios.

Medidas de resultados primarios y secundarios. Los resultados primarios fueron los niveles de conocimiento, actitud y prácticas preventivas hacia el cáncer de piel, medidos mediante el cuestionario validado KAP-SC-Q (Cuestionario de Conocimiento, Actitud y Práctica sobre el Cáncer de Piel) y categorizados como deficientes, moderados o buenos. Los resultados secundarios incluyeron diferencias en KAP según las características sociodemográficas y clínicas, analizadas mediante pruebas t independientes y χ^2.

pruebas.

Resultados Más de la mitad de los participantes demostraron un conocimiento deficiente sobre el cáncer de piel (56,0%) y la gran mayoría mostró prácticas preventivas inadecuadas (84,2%), mientras que las actitudes hacia el cáncer de piel fueron predominantemente positivas (62,4%). Se observaron diferencias significativas en las puntuaciones medias de KAP y niveles categóricos en varias variables sociodemográficas. Los participantes con educación terciaria tuvieron puntuaciones más altas de conocimiento (14,32 vs 12,61) y actitud (20,01 vs 15,95; p<0,001) que aquellos con menor educación. Las personas con un diagnóstico de enfermedad de la piel tuvieron puntuaciones significativamente más altas de conocimiento (14,95 vs 13,03; p=0,001), actitud (20,03 vs 18,21; p=0,007) y práctica (12,10 vs 9,72; p<0,001). Los antecedentes personales de cáncer de piel y quemaduras solares graves se asociaron con mejores prácticas preventivas pero actitudes más negativas (p<0,001), y los participantes de piel clara tenían más probabilidades de tener conocimientos y actitudes deficientes (p<0,05).

Conclusiones: Los adultos malasios mostraron un conocimiento limitado y prácticas preventivas muy deficientes con respecto al cáncer de piel, a pesar de actitudes generalmente positivas. Estos hallazgos resaltan brechas sustanciales entre el conocimiento y el comportamiento y respaldan la necesidad de campañas de salud pública dirigidas.

FORTALEZAS Y LIMITACIONES DE ESTE ESTUDIO

- Se utilizó una versión malasia validada del KAP-SC-Q (Cuestionario de Conocimientos, Actitudes y Prácticas sobre el Cáncer de Piel) para medir los conocimientos, las actitudes y las prácticas relacionadas con el cáncer de piel.
- Se logró un tamaño de muestra suficientemente grande (n=386), que cumple y supera el mínimo requerido para el análisis estadístico.
- El uso del muestreo en cadena en línea puede haber introducido un sesgo de selección, en particular hacia los participantes más jóvenes, urbanos y digitalmente activos.
- Las respuestas autoadministradas en línea pueden verse influenciadas por el sesgo de recuerdo o el sesgo de deseabilidad social.
- El diseño transversal impide establecer relaciones causales entre las variables sociodemográficas y los conocimientos, actitudes y prácticas.

montones.

Intervenciones sanitarias para corregir ideas erróneas, mejorar la percepción del riesgo, especialmente en grupos de alto riesgo, y promover comportamientos eficaces de protección contra la radiación ultravioleta.

INTRODUCCIÓN

El cáncer de piel representa un problema de salud global en aumento, con más de 1,5 millones de casos nuevos reportados solo en 2020, lo que provocó más de 120 000 muertes en todo el mundo.¹ El aumento proyectado de casos de melanoma en un 50 % entre 2020 y 2040 subraya la necesidad urgente de realizar estudios e intervenciones integrales, especialmente dado que la incidencia del cáncer de piel se incrementa en parte debido a una mayor exposición a la radiación ultravioleta (UV); una preocupación exacerbada por el agotamiento de la capa de ozono. Esto es particularmente relevante para regiones ecuatoriales como Malasia, donde la radiación UV penetra con mayor intensidad debido al adelgazamiento de la capa de ozono.² ³

BMJ Open: publicado originalmente como Protegido por derechos de autor. Incluye minería de texto y datos, entrenamiento de IA y tecnologías similares. Descargado de http://bmjopen.bmj.com/ el 29 de octubre de 2026 por invitado.

Machine Translated by Google

El tipo de cáncer más frecuente en el hospital central representó el 34,9% de todos los casos de cáncer de piel. Además, el linfoma cutáneo y el carcinoma de células escamosas representaron el 25,7% y el 20,6% de los casos, respectivamente.3

La radiación ultravioleta (UV) es el principal carcinógeno del cáncer de piel, pero existen otros factores de riesgo.
También desempeñan funciones críticas. Las personas con antecedentes familiares de cáncer de piel tienen un riesgo significativamente elevado, con un aumento de cuatro veces para el carcinoma de células escamosas e incluso mayor para el carcinoma de células basales y múltiples tipos de cáncer de piel, lo que sugiere que las predisposiciones genéticas influyen significativamente en los riesgos de cáncer de piel.4 Otros factores que aumentan el riesgo incluyen el número de lunares, las afecciones cutáneas existentes, el tipo y tono de piel y la presencia de pecas y ampollas, que en conjunto elevan la susceptibilidad al cáncer de piel.

A pesar de su creciente prevalencia, el conocimiento y la comprensión del cáncer de piel entre la población malasia siguen siendo en gran medida desconocidos. Se han realizado pocas investigaciones sobre los conocimientos, las actitudes y las prácticas (CAP) relacionados con el cáncer de piel en Malasia, lo que pone de manifiesto una brecha en la información y el conocimiento sobre salud pública.5
Este estudio pretende subsanar esta deficiencia evaluando los conocimientos, actitudes y prácticas relacionados con el cáncer de piel entre los malayos, ofreciendo información valiosa sobre áreas críticas para la mejora de la comunicación en materia de salud.

Dada la creciente incidencia mundial y local del cáncer de piel, y los múltiples factores de riesgo que contribuyen a su prevalencia, este estudio representa un paso crucial para comprender y mitigar su impacto en Malasia. Por lo tanto, el objetivo de este estudio fue evaluar los niveles de conocimientos, actitudes y prácticas (CAP) sobre la prevención del cáncer de piel entre adultos malasios y analizar cómo varían estos niveles según los diferentes grupos sociodemográficos.

MÉTODOS

Diseño del estudio y población del estudio

Este estudio empleó un diseño transversal para evaluar los conocimientos, actitudes y prácticas (CAP) sobre el cáncer de piel entre adultos malasios.
Esta investigación, realizada en línea entre enero y abril de 2023, recibió la aprobación previa del Comité de Ética de Investigación en Humanos (ID del proyecto: 36701). Los criterios de elegibilidad requerían que los participantes fueran ciudadanos malasios, mayores de 18 años y que hubieran dado su consentimiento para participar. Se excluyó a los profesionales de la salud, incluidos dentistas, enfermeros, farmacéuticos, podólogos y veterinarios, para evitar sesgos profesionales. Los participantes no intervinieron en el diseño, la realización, la presentación de informes ni la difusión de nuestra investigación.

Dada la naturaleza exploratoria de este estudio en el contexto malasio, donde no existen investigaciones previas similares, el tamaño de la muestra se calculó asumiendo una distribución de respuesta del 50 % a las preguntas principales. Utilizando la calculadora de tamaño de muestra de Raosoft con un margen de error del 5 %, un intervalo de confianza del 95 % y una tasa de respuesta esperada del 50 %, se determinó que el tamaño de muestra requerido era de 385 individuos.

Protocolo de estudio

La solicitud de aprobación ética sirvió como protocolo de estudio y guió todos los procesos metodológicos.

Instrumento de encuesta

Los autores desarrollaron un cuestionario validado y fiable antes de llevar a cabo el presente estudio, ya que el primer objetivo de este proyecto era desarrollar y validar el cuestionario con el fin de crear un instrumento para evaluar el nivel de conocimientos, actitudes y prácticas (CAP) del público general con respecto al cáncer de piel.5
Luego realizamos el presente estudio. El cuestionario desarrollado se llama KAP-SC-Q (Cuestionario de Conocimiento, Actitud y Práctica sobre el Cáncer de Piel). La versión definitiva del KAP-SC-Q tenía 108 ítems, divididos en 17 sociodemográficos, 30 de conocimiento, 32 de actitud y 29 de práctica.5 Los ítems de conocimiento tuvieron un rango aceptable de 0,4–2,0 en el análisis de la Teoría de Respuesta al Ítem (TRI), un enfoque psicométrico moderno que evalúa la relación entre las características individuales de los ítems (por ejemplo, parámetros de dificultad y discriminación) y los niveles de rasgos latentes de los encuestados. El Análisis Factorial Exploratorio (AFE) reveló que las secciones de actitud y práctica contribuyeron al 34,25% y al 52,94% de la varianza total observada, respectivamente. El cuestionario se adaptó de un instrumento KAP previamente validado con una fuerte consistencia interna (alfa de Cronbach ≥ 0,81 en todos los dominios).5 El cuestionario completo utilizado en este estudio se proporciona en el archivo complementario en línea 1, y un resumen de sus propiedades psicométricas está disponible en el archivo complementario en línea 2.

Recopilación de datos

Los participantes fueron reclutados mediante la técnica de muestreo en cadena. El cartel con la invitación al estudio, sus detalles y el enlace a la encuesta se difundió a través de plataformas de redes sociales como WhatsApp, Facebook, Instagram y LinkedIn. Las personas interesadas en participar debían hacer clic en el enlace de la encuesta, que las dirigiría al cuestionario en línea.

El cuestionario en línea se alojó en SurveyMonkey (SurveyMonkey, San Mateo, California, EE. UU.). La invitación al estudio se publicó semanalmente para fomentar la participación y la tasa de respuesta. Todos los participantes debían dar su consentimiento informado antes de participar en este estudio.

Participación de pacientes y público

Ni los pacientes ni el público en general participaron en el diseño, la realización, la presentación de informes ni los planes de difusión de esta investigación. La encuesta se administró a la población general sin reclutamiento directo de pacientes. Actualmente no hay planes para difundir los resultados directamente a los participantes.

Análisis de datos

Se utilizó un método de puntuación para cuantificar los niveles de KAP (conocimientos, actitudes y prácticas) sobre el cáncer de piel entre adultos malasios. De acuerdo con el enfoque de puntuación validado informado en trabajos anteriores,5 se asignó un punto por cada respuesta correcta o positiva.

BMJ Open: publicado originalmente como Protegido 10.1136/bmjopen-2025-103040 el 22 de febrero de

Descargado de http://bmjopen.bmj.com/ el 29 de octubre de 2026 por invitado

Machine Translated by Google

Se asignaron puntos por respuestas incorrectas, inseguras o negativas, y puntos cero por respuestas incompletas.

Se calcularon las puntuaciones totales de conocimiento (30 ítems), actitudes (32 ítems) y prácticas (29 ítems), y posteriormente se clasificaron en tres niveles (bajo, moderado y bueno) según los puntos de corte establecidos y validados durante el desarrollo del cuestionario. Por ejemplo, las puntuaciones de conocimiento se clasificaron como bajas (0-15), moderadas (16-23) y buenas (24-30). Los ítems de actitud y práctica se midieron inicialmente mediante una escala Likert de 5 puntos y posteriormente se dicotomizaron para su puntuación, donde "de acuerdo" y "totalmente de acuerdo" se codificaron como positivas (1), y todas las demás respuestas se codificaron como negativas (0).

Se utilizaron estadísticas descriptivas, incluyendo medias, desviaciones estándar y frecuencias, para resumir las características de los participantes y los niveles de conocimientos, actitudes y prácticas (CAP). Las diferencias entre grupos en las puntuaciones medias de CAP se analizaron mediante pruebas t independientes, mientras que las asociaciones entre las variables sociodemográficas y los resultados de CAP categorizados se evaluaron mediante pruebas de chi-cuadrado.

Para examinar con mayor detalle los factores asociados a las malas prácticas de prevención del cáncer de piel, se realizó un análisis de regresión logística binaria multivariable. La práctica preventiva se dicotomizó en deficiente frente a moderada/buena y se introdujo como variable dependiente. Las variables independientes se seleccionaron a priori en función de su relevancia clínica y la literatura previa, e incluyeron el grupo de edad, el sexo, el nivel educativo, el lugar de residencia, el tono de piel, los antecedentes personales de cáncer de piel y los antecedentes de quemaduras solares graves. Se informaron los OR ajustados con intervalos de confianza del 95 % para cuantificar la fuerza de las asociaciones.

En todos los casos se presentan los valores p exactos. La significación estadística se estableció en p<0,05. Todos los análisis se realizaron con el software SPSS (V.26.0; IBM, Armonk, Nueva York, EE. UU.).

RESULTADOS

Características sociodemográficas de los participantes

Un total de 386 participantes completaron el cuestionario. La edad promedio de los participantes fue de 27,84 ± 16,9 años, y la mayoría eran mujeres (55,44 %). La etnia predominante fue la china (65,54 %), y la mayoría contaba con estudios superiores (76,94 %). La mayoría de los participantes residía en zonas urbanas (86,53 %).

En cuanto a la exposición al sol, la mayoría de los participantes estuvieron expuestos al sol durante menos de 1 hora al día (49,22%). Aproximadamente una cuarta parte de los participantes tenía antecedentes personales de cáncer de piel (23,83%), y aproximadamente una quinta parte tenía antecedentes familiares de cáncer de piel (17,10%). Alrededor de la mitad de los participantes fueron diagnosticados con alguna enfermedad de la piel (46,37%).

La mayoría de los participantes tenían un tono de piel bronceado (49,22%), un tipo de piel tipo 3 (23,32%) y un número bajo de lunares (0-50) (82,64%). Casi una cuarta parte de los participantes, sin embargo, tenían lunares inusuales (23,58%). La mitad de los participantes no experimentaron ningún problema de pérdida o debilitamiento del cabello (50,52%), y alrededor de dos tercios de los participantes no tenían pecas (61,14%). En Además, cerca de un tercio de los participantes sufrieron quemaduras solares graves que les provocaron ampollas (30,57%). En la tabla complementaria 1 disponible en línea se muestran más detalles.

Nivel de conocimiento, actitud y práctica respecto al cáncer de piel

Según los datos disponibles, se observó que los participantes presentaban un nivel de conocimiento subóptimo sobre el cáncer de piel (56,0%), y el 84,2% mostraba medidas preventivas inadecuadas. Esto evidencia una deficiencia significativa en la comprensión de la enfermedad, lo cual podría contribuir a la falta de concienciación en la práctica para prevenir el cáncer de piel. Curiosamente, la mayoría de los participantes tenía una actitud positiva hacia el cáncer de piel, lo que indica un buen avance en la promoción de la concienciación, tanto en conocimientos como en prácticas, como se muestra en la figura 1.

Si bien la puntuación media general de actitud fue moderada, los ítems individuales mostraron respuestas mayoritariamente positivas (de acuerdo o totalmente de acuerdo). Estas percepciones favorables no se tradujeron en comportamientos preventivos, lo que resultó en puntuaciones bajas en las prácticas.

Conocimientos de los participantes sobre el cáncer de piel

En general, se observó que el conocimiento sobre el cáncer de piel entre los participantes malasios podría mejorarse (archivo complementario en línea 3). Es alentador que el 79,79 % de los participantes identificara correctamente que las personas con antecedentes familiares o personales de cáncer de piel son más susceptibles a padecerlo. La comprensión de los factores de riesgo del cáncer de piel es crucial para la detección temprana y la prevención de la enfermedad. Sin embargo, resulta preocupante que solo el 39,90 % de los participantes reconociera que la radiación ultravioleta del sol no es la única causa del cáncer de piel, ya que existen otros factores de riesgo.

Además, un número considerable de participantes (70,73%) reconoció correctamente que la detección del cáncer de piel implica la identificación de lunares, marcas de nacimiento u otras marcas que sean inusuales en color, tamaño, forma o textura, y que también podrían autoexaminar rutinariamente el estado de su piel.

Sin embargo, entre los participantes existían ideas erróneas sobre el cáncer de piel. Por ejemplo, el 18,65% creía que las personas con piel que se quema o se llena de pecas fácilmente tienen un menor riesgo de padecer cáncer de piel, mientras que el 42,23% no estaba seguro de este aspecto. Esta idea errónea podría llevar a una protección solar inadecuada para quienes presentan estas características cutáneas. Del mismo modo, aproximadamente una cuarta parte de los participantes (26,68%) creía que un protector solar con factor de protección solar (FPS) 30 se refiere al nivel de protección que ofrece contra la radiación ultravioleta B (UVB); teóricamente, un FPS 30 significa que el eritema (quemadura solar) tardaría aproximadamente 30 veces más en aparecer en la piel protegida que en la no protegida; sin embargo, el 22,28% no estaba seguro de esto, lo que posiblemente indica una falta de conocimiento sobre la protección solar ad uso de protector solar.

BMJ Open: publicado originalmente como Protegido por derechos de autor, incluidos los usos de minería de texto y datos, el entrenamiento de IA y tecnologías similares. Descargado de http://bmjopen.bmj.com/ el 29 de octubre de 2026 por invitado

Machine Translated by Google

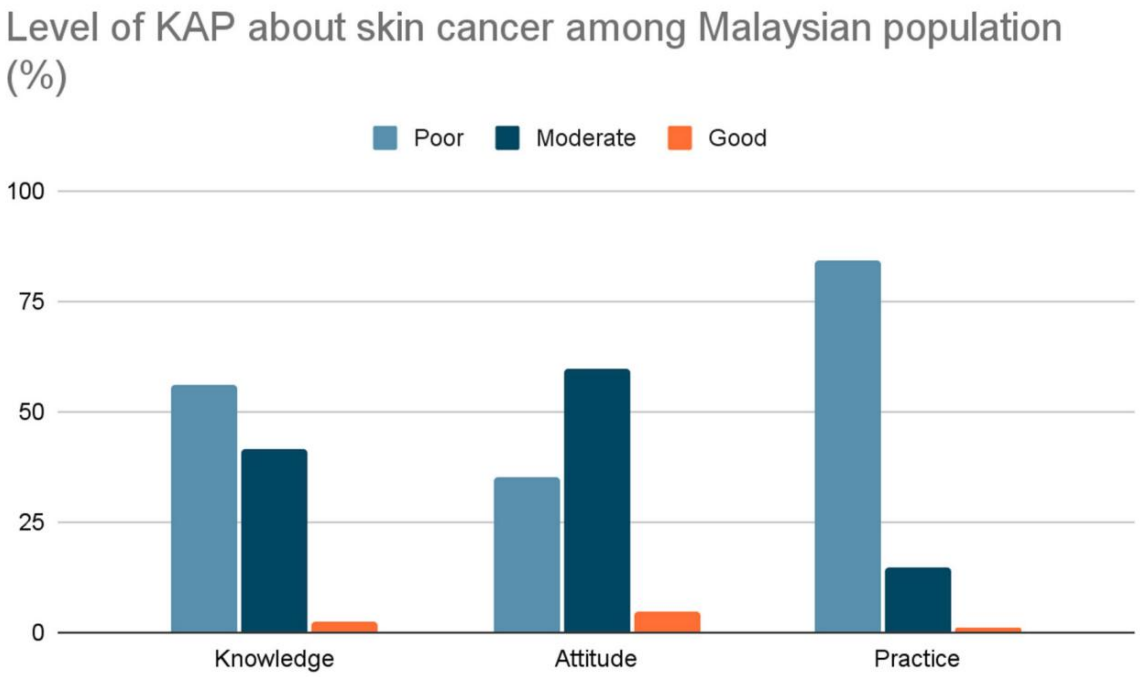


Figura 1. Nivel de conocimiento, actitud y práctica sobre el cáncer de piel entre los participantes. CAP: conocimiento, actitud y práctica.

Los antioxidantes como estrategia protectora para reducir el riesgo de cáncer de piel. Si bien los antioxidantes son beneficiosos para la salud en general, su papel específico en la prevención del cáncer de piel sigue siendo incierto, lo que sugiere la necesidad de difundir información más precisa.

Actitud de los participantes hacia el cáncer de piel

En general, los participantes mostraron una actitud alentadora hacia el cáncer de piel; sin embargo, se observaron varios conceptos erróneos e incertidumbres que deben abordarse (archivo complementario en línea 3). Como aspecto positivo, más de la mitad de los participantes (60,62 %) coincidió en que el cáncer de piel es un problema cutáneo que puede causar la muerte, lo que subraya su reconocimiento de la gravedad de la enfermedad y la importancia de la detección y prevención tempranas. Una proporción similar de participantes (57,77 %) coincidió en que el cáncer de piel es altamente prevenible, lo que demuestra un buen conocimiento de su prevenibilidad y el impacto potencial de las iniciativas educativas para reducir su incidencia.

Sin embargo, casi la mitad de los participantes (45,60%) no estuvo de acuerdo en que el cáncer de piel sea totalmente incurable, lo que indica una posible complacencia respecto a las medidas preventivas y la intervención temprana en su tratamiento. Asimismo, un número similar de participantes (44,04%) coincidió en que la cantidad de lunares no afecta el riesgo de padecer cáncer de piel, lo que podría llevar a una falta de atención a los cambios en los lunares y, por consiguiente, a un retraso en la detección del cáncer. Además, solo el 33,68% estuvo de acuerdo en que el riesgo de melanoma se duplica en personas con pecas, lo que sugiere la necesidad de intervenir para educar al público sobre la relación entre las pecas y el riesgo de cáncer de piel.

En medio de estas ideas erróneas, los participantes expresaron una actitud positiva hacia la prevención del cáncer de piel. Por ejemplo, el 57,51 % de los participantes coincidió en que las personas de piel oscura requieren la misma protección y revisiones periódicas que las de piel clara, lo que demuestra que reconocen la importancia de la protección solar para todo tipo de piel. Además, el 58,03 % estuvo de acuerdo en que observar cualquier anomalía, erupción o inflamación en la piel es un método de detección del cáncer de piel, lo que evidencia su conocimiento y vigilancia para identificar posibles signos de la enfermedad.

Prácticas de los participantes para la prevención del cáncer de piel

Los resultados mostraron que los participantes necesitarían más apoyo para mejorar sus prácticas de prevención del cáncer de piel (archivo complementario en línea 3). Si bien un número significativo de participantes aplicó medidas preventivas esenciales, hubo áreas que requerían mayor atención y mejora.

Por ejemplo, en lo que respecta al autoexamen, más de la mitad de los participantes (60,43%) realizan a veces, a menudo o siempre autoexámenes anuales exhaustivos de la piel.
Sin embargo, casi la mitad de ellos (48,70%) no acudieron a ningún profesional sanitario para realizarse un examen de la piel anualmente.

Aproximadamente entre el 20,0% y el 40,0% de los participantes no practicaban medidas preventivas adecuadas al exponerse al sol, ya que nunca usaban sombreros de ala ancha para protegerse la cara, la cabeza, las orejas y el cuello, ni ropa con protección UV al salir al aire libre, y rara vez o nunca se volvían a aplicar protector solar después de nadar o sudar en exceso. Para actividades que implican una exposición solar prolongada, como la natación, casi la mitad de ellos (44,15%) no se volvían a aplicar protector solar después de secarse con la toalla. Además, solo el 33,01% de los participantes utilizaban una radiación ultravioleta A (UVA) y ultravioleta B (UVB) más fuerte, donde la UVA

BMJ Open: publicado originalmente como Protegido 10.1136/bmjopen-2025-103040 el 22 de febrero de

Descargado de http://bmjopen.bmj.com/ el 29 de octubre de 2026 por invitado

Machine Translated by Google

Penetra más profundamente en la piel y contribuye al fotoenvejecimiento y la carcinogénesis, mientras que los rayos UVB son los principales responsables de las quemaduras solares y el daño directo al ADN, con un FPS 50 o superior, lo que sugiere la necesidad de una intervención educativa sobre la importancia de utilizar una protección solar adecuada.

En determinados entornos laborales que podrían conllevar un mayor riesgo de cáncer de piel, aproximadamente un tercio de los participantes (32,64 %) no se sometieron a pruebas de biopsia cutánea según los calendarios de cribado recomendados.

Diferencias entre variables sociodemográficas y la media de la puntuación KAP (¿Predictores de las categorías KAP?)

Según la tabla suplementaria en línea 2, surgen varias conclusiones clave sobre los conocimientos, actitudes y prácticas (CAP) relacionados con el cáncer de piel entre los diferentes grupos sociodemográficos de los participantes. Aquellos con antecedentes personales o familiares de cáncer de piel, a pesar de tener puntuaciones de actitud más bajas (16,89 y 16,85, ambos con p<0,001), demuestran mejores prácticas (13,14 y 13,65, con p<0,001), lo que sugiere comportamientos más preventivos en estos grupos de alto riesgo. Las personas con educación terciaria tienen conocimientos superiores (14,32, p=0,032) y actitudes (20,01, p<0,001) hacia el cáncer de piel, lo que implica la importancia de la educación para promover la concienciación. Sin embargo, esto no se traduce en mejores puntuaciones de práctica (10,63, p=0,161), lo que sugiere una brecha entre la concienciación y los comportamientos preventivos reales.

Además, las personas diagnosticadas con enfermedades de la piel muestran puntuaciones KAP más altas (conocimiento: 14,95, p=0,001; actitud: 20,03, p=0,007; práctica: 12,10, p<0,001), lo que subraya el papel crucial de las afecciones cutáneas preexistentes en la formación de la concienciación y la prevención del cáncer de piel. Adicionalmente, las personas que han sufrido quemaduras solares graves que provocan ampollas muestran actitudes más negativas hacia el cáncer de piel (17,48, p=0,002) pero exhiben mejores prácticas (12,33, p<0,001), lo que indica una posible dicotomía entre actitudes y prácticas en aquellos con daño solar directo.

Por último, el tono y el tipo de piel influyen significativamente en las actitudes y prácticas: las personas con tonos de piel claros muestran actitudes menos favorables (13,73; p = 0,006), mientras que las personas con tipo de piel 1 (que se queman con facilidad, no se broncean y son sensibles a la exposición a los rayos UV) presentan prácticas menos favorables (9,94; p = 0,007). Esto podría deberse a una mayor vulnerabilidad a las quemaduras solares y al cáncer de piel, lo que subraya la necesidad de programas de concienciación más específicos para estos grupos demográficos, como se muestra en la tabla complementaria 2 en línea.

Asociación significativa entre el nivel de conocimientos, actitudes y prácticas (CAP) y las variables demográficas.

Los datos de la tabla suplementaria en línea 3 proporcionan una asociación significativa entre el conocimiento sobre el cáncer de piel y los antecedentes personales de cáncer de piel, los antecedentes familiares de cáncer de piel, el diagnóstico de otras enfermedades de la piel y el tono de la piel. Por ejemplo, el 67,4% de las personas con antecedentes personales de cáncer de piel tienen un conocimiento deficiente sobre la enfermedad (p=0,040). Esto es sorprendente, ya que cabría esperar que estas personas estuvieran más informadas sobre la enfermedad. De manera similar, aquellos con antecedentes familiares de cáncer de piel muestran un 60,6% con un conocimiento deficiente, que es ligeramente inferior pero aún significativo.

Por otro lado, el 48,0% de las personas diagnosticadas con otras enfermedades de la piel tienen escasos conocimientos sobre el cáncer de piel (p=0,014), lo que implica que el diagnóstico de cualquier afección cutánea podría aumentar la concienciación sobre las enfermedades de la piel. Finalmente, un hallazgo importante es que el 93,3% de las personas de piel clara, que son más susceptibles al cáncer de piel, tienen escasos conocimientos sobre la enfermedad (p=0,036).

Curiosamente, las personas con antecedentes personales (52,7%, p<0,001) o familiares (54,5%, p<0,001) de cáncer de piel —grupos que normalmente se espera que sean más vigilantes—
También muestran actitudes negativas. Los datos revelan una tendencia alarmante: las personas más susceptibles al cáncer de piel, como las de piel clara (73,3 %, p = 0,033) y las que tienen antecedentes de quemaduras solares graves (48,3 %, p = 0,001), suelen mantener actitudes negativas hacia la enfermedad, como se muestra en la tabla complementaria 4 en línea.

Además, la tabla complementaria en línea 5 revela una asociación significativa entre las prácticas de protección de la piel y los antecedentes médicos de cáncer de piel y enfermedades cutáneas. Cabe destacar que las personas con antecedentes personales de cáncer de piel presentaban un mayor porcentaje de prácticas moderadas de protección de la piel (32,6 %) en comparación con aquellas sin antecedentes (9,2 %). Se observa un patrón similar en las personas con antecedentes familiares de cáncer de piel, donde el 34,8 % exhibe prácticas moderadas de protección de la piel frente al 10,6 % en aquellas sin antecedentes familiares. Estos hallazgos subrayan la influencia de los antecedentes médicos personales y familiares en la implementación de prácticas de protección de la piel.

Por último, la tabla complementaria en línea 6 presenta los resultados del análisis de regresión logística multivariable que examina los factores asociados con malas prácticas de prevención del cáncer de piel entre adultos malasios. Después del ajuste por variables sociodemográficas y clínicas relevantes, el sexo masculino se asoció significativamente con una mayor probabilidad de malas prácticas preventivas (OR ajustado = 1,85, IC del 95 %: 1,22 a 2,80, p = 0,004). Los participantes con educación no terciaria también tuvieron una probabilidad significativamente mayor de malas prácticas preventivas en comparación con aquellos con educación terciaria (OR ajustado = 2,14, IC del 95 %: 1,39 a 3,30, p = 0,001). El tono de piel claro se asoció de forma independiente con una mayor probabilidad de prácticas preventivas deficientes (OR ajustado = 1,76; IC del 95 %: 1,05 a 2,94; p = 0,032), al igual que los antecedentes de quemaduras solares graves (OR ajustado = 1,67; IC del 95 %: 1,10 a 2,54; p = 0,016). Por el contrario, los participantes con antecedentes personales de cáncer de piel fueron menos propensos a reportar prácticas preventivas deficientes (OR ajustado = 0,58; IC del 95 %: 0,36 a 0,93; p = 0,024).

En el modelo ajustado, la edad igual o superior a 30 años y la residencia urbana no se asociaron significativamente con malas prácticas preventivas.

DISCUSIÓN

Conocimientos, actitudes y prácticas con respecto al cáncer de piel.

El cáncer de piel se ha reconocido como una preocupación creciente a nivel mundial y particularmente en Malasia.7 Sin embargo, pocos estudios en Malasia han evaluado los conocimientos, actitudes y prácticas (CAP) del público sobre el cáncer de piel. Este estudio busca llenar este vacío.

BMJ Open: publicado originalmente como Protegido por derechos de autor, incluido el entrenamiento de IA, tecnologías similares y minería de texto y datos. el 29 de octubre de 2026 por invitado. Descargado de http://bmjopen.bmj.com/ el 29 de octubre de 2026 por invitado.

Machine Translated by Google

Separar la literatura existente mediante la identificación de los conocimientos, actitudes y prácticas (CAP) de los malayos sobre el cáncer de piel utilizando un cuestionario adaptado y validado.

Los hallazgos revelaron una brecha de conocimiento significativa con respecto al cáncer de piel. Muchos participantes desconocían que la radiación ultravioleta del sol es una de las principales causas de cáncer de piel, en consonancia con los hallazgos de Schadendorf y sus colegas.8 Además, la mayoría de los participantes no se dieron cuenta de que los hombres y aquellos con piel más clara o quemaduras frecuentes/
Las personas con pecas son más susceptibles al cáncer de piel. Otra idea errónea común es que las personas con piel más oscura son menos susceptibles.9 Además, la creencia errónea de que el melanoma solo se desarrolla en áreas expuestas al sol es alarmante, considerando su naturaleza mortal.10 A pesar de estas lagunas, la mayoría de los participantes reconocieron la importancia de la detección e intervención tempranas.

En cuanto a la actitud, si bien la mayoría de los participantes comprendían la gravedad del cáncer de piel, varias ideas erróneas podrían dificultar una prevención eficaz. La falta de exámenes cutáneos regulares y los supuestos beneficios de tomar el sol evidenciaron aún más la necesidad de campañas de salud pública específicas para abordar la desinformación sobre el cáncer de piel y las medidas de protección.^{11,12}

En cuanto a la práctica, la mayoría de los participantes desconocían la importancia del autoexamen para la detección temprana del cáncer de piel. Aunque muchos participantes tenían un gran conocimiento sobre el uso de protector solar y sus beneficios, su aplicación seguía siendo inconsistente, especialmente entre los participantes. Las recomendaciones sobre ropa de hombres.[13 14] protección solar también eran limitadas, y la mayoría desconocía las mejores opciones de telas para la protección UV.¹⁵

Nuestros resultados coinciden con investigaciones de otras regiones que muestran una brecha constante entre la concienciación y las conductas preventivas. Entre los estudiantes de medicina jordanos, el alto conocimiento de los factores de riesgo del cáncer de piel no se tradujo en acciones concretas: el 61,5 % declaró no haberse realizado nunca un autoexamen de la piel y el 20 % no usar protector solar en absoluto.¹⁶ Del mismo modo, un estudio multicéntrico en Arabia Saudita halló que, si bien los estudiantes reconocían la importancia de la protección UV, el 30 % nunca usaba protector solar y el 57 % no se lo volvía a aplicar, siendo su uso motivado principalmente por razones cosméticas más que por la prevención del cáncer.¹⁷ Estos hallazgos refuerzan la idea de que el conocimiento y las actitudes por sí solos no conducen de forma fiable a conductas protectoras, lo que subraya la necesidad de intervenciones específicas que mejoren los hábitos prácticos de prevención.^{16–20}

Se han reportado patrones similares en todo el sudeste asiático. En Tailandia, una encuesta realizada a más de 10 000 estudiantes de secundaria en Bangkok reveló que los comportamientos de protección solar eran deficientes en comparación con las poblaciones occidentales, con un uso particularmente bajo de protector solar, sombreros y ropa protectora, y una protección consistentemente menor entre los estudiantes varones.18 En Indonesia, los estudiantes universitarios mostraron brechas entre el conocimiento sobre la radiación ultravioleta y el comportamiento fotoprotector real, y muchos reportaron un uso inconsistente de protector solar y otras medidas de protección a pesar de tener niveles de conocimiento razonables.19 En Singapur, una encuesta nacional a adultos identificó bajas puntuaciones generales de protección solar y mostró que la edad más joven, el sexo masculino y la piel más oscura se asociaban con una menor protección solar.

El tipo de piel y un menor nivel educativo se asociaron con una mayor exposición al sol y peores hábitos de protección solar.20 Estos hallazgos regionales son consistentes con nuestros resultados y sugieren que los factores sociodemográficos y la percepción de baja vulnerabilidad contribuyen a comportamientos de prevención subóptimos en entornos asiáticos con alta radiación UV.

Las influencias culturales y estéticas también pueden afectar los comportamientos de protección solar en Malasia. Al igual que en Oriente Medio y otras poblaciones asiáticas, el uso de protector solar se percibe a menudo principalmente como un producto cosmético más que como una necesidad de salud, especialmente entre los hombres. Por ejemplo, un estudio en Arabia Saudita informó que el protector solar se usaba principalmente para prevenir el bronceado más que para reducir el riesgo de cáncer de piel, y el 38,2 % citó razones cosméticas como su principal motivación.17 18 20 Estas creencias pueden reducir la participación en prácticas preventivas, a pesar de las actitudes generalmente favorables hacia el cáncer de piel.

Diferencias y asociaciones entre factores sociodemográficos y conocimientos, actitudes y prácticas (CAP, por sus siglas en inglés).

El estudio reveló que quienes tenían antecedentes de cáncer de piel presentaban un conocimiento deficiente sobre la enfermedad, contrariamente a lo esperado. Una posible razón es la alfabetización en salud; un bajo nivel de alfabetización puede dificultar la comprensión de la información sobre el cáncer de piel. Las fuentes poco fiables y la mala comunicación entre médicos y pacientes también podrían contribuir a ello. Los hombres mostraron actitudes negativas hacia el cáncer de piel, lo cual concuerda con estudios previos que demuestran diferencias de género en la percepción del riesgo y en la búsqueda de atención médica. [21–23] Por otro lado, las mujeres practicaban mejores medidas preventivas, y estudios como los de las referencias 22 , 24 y 25 confirman un mayor uso de protector solar por parte de las mujeres. Esto puede deberse a la alfabetización en salud, las expectativas sociales o ambas. Resulta preocupante que los hombres mayores de 65 años sean más susceptibles al melanoma que las mujeres, como lo señalan estudios epidemiológicos previos.[23]

Además, una mayor educación se correlaciona con mejores actitudes hacia el cáncer de piel, lo que coincide con los hallazgos de estudios poblacionales previos.26 Quienes tienen mayor nivel educativo comprenden los riesgos del cáncer de piel y son proactivos en su prevención. Los esfuerzos de salud pública deberían centrarse en las poblaciones con bajo nivel educativo, ofreciéndoles información clara y accesible. Resulta preocupante que nuestro análisis mostrara que las personas de piel clara, especialmente aquellas con antecedentes de quemaduras solares graves, descuidan las precauciones contra el cáncer de piel. Investigaciones previas vinculan los antecedentes de quemaduras solares con los patrones de uso de protectores solares y el riesgo de cáncer de piel a largo plazo.27 28 Quienes se queman con el sol antes de los 25 años se enfrentan a mayores riesgos de cáncer de piel. Las personas de piel clara, especialmente las de ascendencia china, corren mayor riesgo, como se observa en estudios regionales que documentan una mayor vulnerabilidad entre las poblaciones asiáticas de piel más clara.29 30

Por último, en lo que respecta a la prevención, los malayos muestran malas prácticas, influenciadas por la etnia, la educación y el tipo de piel. Muchos creen erróneamente que la piel más oscura proporciona inmunidad, lo que resulta en autocontroles inadecuados, como se afirma. [31] La educación desempeña un papel fundamental, y estudios como estos demuestran la influencia positiva de la educación en la concienciación sobre el cáncer de piel.21 32

Finalmente, el tipo de piel afecta significativamente las prácticas, según estudios.

BMJ Open: publicado originalmente como Protegido 10.1136/bmjopen-2025-103040 el 22 de febrero de

Descargado de http://bmjopen.bmj.com/ el 29 de octubre de 2026 por invitado

Machine Translated by Google

lo que indica que las personas de piel clara se enfrentan a mayores riesgos y, por lo tanto, requieren campañas de concienciación específicas.29 33

Por lo tanto, los resultados del estudio subrayan la necesidad de campañas de salud pública personalizadas para abordar las ideas erróneas y enfatizar el conocimiento basado en la evidencia. La colaboración con organismos dermatológicos podría aumentar la credibilidad y la confianza en la información proporcionada. Las medidas de salud pública deben destacar la importancia de la detección temprana y la necesidad de una protección solar constante para todos los tipos de piel.

Estos hallazgos respaldan la necesidad de estrategias nacionales de salud pública que hagan hincapié en comportamientos preventivos prácticos en lugar de centrarse únicamente en aumentar la concienciación.
Las campañas deben priorizar la enseñanza del uso correcto del protector solar, el fomento del autoexamen rutinario de la piel y la promoción de la ropa protectora, especialmente dirigidas a los jóvenes y los hombres. La colaboración con universidades, centros de atención primaria y plataformas de redes sociales puede ampliar el alcance. Dado que el uso de protector solar suele estar motivado más por razones estéticas que por motivos de salud en las poblaciones regionales,[1] las campañas de salud podrían beneficiarse al presentar los beneficios de la protección solar de forma que resulten atractivas tanto para la estética como para la prevención médica.

Resumen del artículo

Según nuestro conocimiento, este fue uno de los estudios pioneros que exploraron los conocimientos, actitudes y prácticas (CAP) sobre el cáncer de piel en Malasia. Esto nos permitió identificar áreas potenciales de mejora a través de una intervención educativa específica para brindar información al público de manera efectiva.
manera.

La generalización de este estudio se ve limitada por el uso del muestreo en cadena basado en redes sociales, que puede representar de forma desproporcionada a personas más jóvenes, urbanas, con mayor nivel educativo y más activas digitalmente. La muestra también estuvo sesgada hacia los encuestados chinos, lo que no refleja completamente la estructura demográfica multiétnica de Malasia.
Si bien se alcanzó el tamaño de muestra requerido, no se puede garantizar la representatividad debido al posible sesgo de selección y a la naturaleza de autoselección de la participación voluntaria en línea.

Los datos se recopilaron mediante respuestas autoinformadas, lo que puede introducir un sesgo de deseabilidad social, especialmente en prácticas preventivas como el uso de protector solar y el autoexamen de la piel. Se excluyó intencionadamente a los profesionales sanitarios para evitar sobreestimar el conocimiento público y las puntuaciones de comportamiento preventivo; sin embargo, esta restricción limita la comparación entre la población general y los profesionales con formación clínica.

Además, el diseño transversal impide establecer relaciones causales, y las asociaciones observadas no deben interpretarse como relaciones predictivas. Los estudios futuros deberían considerar métodos de muestreo probabilístico o estratificado para mejorar la representatividad.

CONCLUSIÓN

Este estudio concluyó que la mayoría de los participantes demostraron niveles subóptimos de conocimiento y práctica.

En relación con el cáncer de piel y su prevención, se observó una actitud moderadamente positiva hacia esta afección cutánea. Esta discrepancia entre el conocimiento y las medidas preventivas reales pone de manifiesto una brecha crucial que requiere atención urgente. Por lo tanto, este estudio constituye un llamado a la acción para los profesionales de la salud, educadores y responsables políticos de Malasia, instándolos a reconocer y abordar la compleja problemática del conocimiento sobre el cáncer de piel.

Es imperativo cerrar la brecha entre el conocimiento y la práctica, y se requieren esfuerzos específicos para avanzar en la prevención y la detección temprana del cáncer de piel en la población malasia. El esfuerzo colectivo contribuirá a salvaguardar la salud pública y, potencialmente, salvará vidas al reducir la incidencia y el impacto de esta enfermedad grave pero prevenible.

Colaboradores Conceptualización: AHM, BARH, AB, JD; Curación de datos: AHM, LHY, MLBH, AWSN, LSY, MLBH; Análisis formal: AB, JD, LJJ, AHM, LHY, MLBH, AWSN, LSY; Investigación: AHM, LHY, MLBH, AWSN, LSY; Metodología: AHM, LHY, MLBH, AWSN, LSY; Administración de proyectos: LHY, MLBH, AWSN, LSY; Recursos: AB, JD, AHM, LHY, MLBH, AWSN, LSY, AB; Software: AHM, LHY, MLBH, AWSN, LSY; Supervisión: AHM, BARH, DSR, AB, JD; Validación: AHM, BARH, DSR; Visualización: AHM, BARH, DSR; Redacción: borrador original: AHM, LJJ, LHY, MLBH, AWSN, LSY, AB, YJW; Redacción, revisión y edición: AB, JD, YJW, HSH. Garante: AHM.

Financiación: Los autores no han declarado ninguna subvención específica para esta investigación por parte de ninguna agencia de financiación de los sectores público, comercial o sin ánimo de lucro.

Conflictos de intereses: Ninguno declarado.

Participación de pacientes y público: Ni los pacientes ni el público participaron en el diseño, la realización, la presentación de informes ni los planes de difusión de esta investigación.

Consentimiento del paciente para la publicación. Consentimiento obtenido directamente del/de los paciente(s).

Aprobación ética: El Comité de Ética de Investigación en Humanos de la Universidad de Monash aprobó este estudio (MUHREC-36701). La investigación se llevó a cabo de acuerdo con los principios éticos establecidos en la Declaración de Helsinki. El investigador explicó el propósito del estudio, los riesgos y beneficios potenciales, así como el anonimato de los participantes. Se garantizó la confidencialidad al asegurar que no se recopilara información demográfica que permitiera identificar a los participantes. Se les informó que los datos serían anonimizados y que no se recopilarían datos personales. Antes de completar los cuestionarios, los participantes recibieron una Hoja Informativa y se obtuvo su consentimiento informado mediante su firma.

Procedencia y revisión por pares: No fue un encargo; fue revisado externamente por pares.

Declaración de disponibilidad de datos: Los datos están disponibles en un repositorio público de acceso abierto. Los datos anonimizados, el instrumento de encuesta y el conjunto de datos codificados con SPSS utilizados en este estudio están disponibles públicamente en un repositorio público. Se puede acceder a los materiales en el siguiente enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1a5-irJmoRNmcW0oxnO4K-jjoXunpDcsg?usp=drive_link. Los datos se comparten de acuerdo con las directrices de MUHREC y sin identificadores.

Material complementario . Este contenido ha sido proporcionado por el/los autor/es. No ha sido revisado por BMJ Publishing Group Limited (BMJ) y es posible que no haya sido sometido a revisión por pares. Las opiniones o recomendaciones aquí expresadas son responsabilidad exclusiva del/de los autor/es y no cuentan con el respaldo de BMJ. BMJ declina toda responsabilidad derivada del uso de este contenido. En caso de que el contenido incluya material traducido, BMJ no garantiza la exactitud ni la fiabilidad de las traducciones (incluidas, entre otras, las normativas locales, las guías clínicas, la terminología, los nombres y las dosis de los medicamentos), y no se responsabiliza de los errores u omisiones derivados de la traducción, la adaptación o cualquier otra circunstancia.

Acceso abierto. Este es un artículo de acceso abierto distribuido bajo la licencia Creative Commons Attribution 4.0 Unported (CC BY 4.0), que permite a otros copiar, redistribuir, remezclar, transformar y desarrollar esta obra para cualquier propósito, siempre que se cite correctamente la obra original, se proporcione un enlace a la licencia y se indique si se realizaron cambios. Véase: https://creativecommons.org/licencias/por/4.0/.

ORCID iD
Ali Blebil https://orcid.org/0000-0002-7480-1260

BMJ Open: publicado originalmente como Protegido 10.1136/bmjopen-2025-103040 el 22 de febrero de

Descargado de http://bmjopen.bmj.com/ el 29 de octubre de 2026 por invitado

Machine Translated by Google

REFERENCIAS

1 Phillips RL, Moody MP, Hohman MH, et al. Melanoma metastásico: una consecuencia de la pandemia de COVID-19. Cureus 2023;15:e38397.
2 Arnold M, Singh D, Laversanne M, et al. Carga global del melanoma cutáneo en 2020 y proyecciones hasta 2040. JAMA Dermatol 2022;158:495–503.
3 Affandi AM. ¿Es común el cáncer de piel en Malasia? The Star Online; 2015.2018.
4 Asgari MM, Warton EM, Whittemore AS. Antecedentes familiares de piel El cáncer se asocia con un mayor riesgo de carcinoma de células escamosas cutáneo. Dermatol Surg 2015;41:481–6.
5 Mohammed AH, Ying LH, Boon Hong ML, et al. Desarrollo y Validación de un cuestionario de conocimientos, actitudes y prácticas (CAP) sobre cáncer de piel en la población general: KAP-SC-Q. Res Social Adm Pharm 2024;20:124–36.
6 SurveyMonkey Inc. Herramienta de encuestas en línea SurveyMonkey. San Mateo, CA, 2023. Disponible en: https://www.surveymonkey.com
7 Garcovich S, Colloca G, Sollena P, et al. Epidemias de cáncer de piel en ancianos como un problema emergente en oncología geriátrica. Aging Dis 2017;8:643–61.
8 Schadendorf D, Fisher DE, Garbe C, et al. Melanoma. Nat Rev Dis Imprimaciones 2015;1:15003.
9 Bryant J, Zucca A, Brozek I, et al. Actitudes de protección solar y comportamientos entre australianos de primera generación con tipos de piel más oscuros: resultados de grupos focales. J Immigr Minor Health 2015;17:248–54.
10 Gandini S, Sera F, Cattaruzza MS, et al. Metaanálisis de factores de riesgo para el melanoma cutáneo: III. Antecedentes familiares, daño actínico y factores fenotípicos. Eur J Cancer 2005;41:2040–59.
11 Sinclair C, Foley P. Prevención del cáncer de piel en Australia. Br J Dermatol 2009;161 Supl. 3:116–23.
12 Nahar VK, Wilkerson AH, Pearlman RL, et al. Relacionado con el cáncer de piel Conocimientos, actitudes, creencias y prácticas entre la población de los países del Consejo de Cooperación del Golfo: una búsqueda sistemática y revisión de la literatura. Arch Dermatol Res 2020;312:533–44.
13 Almuqati RR, Alamri AS, Almuqati NR. Conocimientos, actitudes y prácticas sobre la exposición al sol y el uso de protección solar entre estudiantes universitarias no médicas en Arabia Saudita: un estudio transversal. Int J Womens Dermatol 2019;5:105–9.
14 Korrapati NH, Naz S, Swamy PK, et al. Uso de protector solar entre mujeres del sur de Asia: una encuesta. IJPSAT 2021;27:19.
15 Berry EG, Bezecny J, Acton M, et al. Slip versus Slop: A Head-to- Comparación de prendas con protección UV y protectores solares. Cáncer (Basilea) 2022;14:542.
16 Seetan K, Khamees A, Migdadi A, et al. Conocimientos, actitudes y prácticas sobre la prevención y detección del cáncer de piel entre estudiantes de medicina jordanos: un estudio transversal. J Skin Cancer 2022;2022:6989827.
17 Memon MM, Manzoor M, Ashrafi MM, et al. Prevalencia y Factores predictivos del uso de protector solar entre estudiantes de medicina: un estudio transversal multicéntrico. Cureus 2019;11:e4926.
18 Tempark T, Chatproedprai S, Wananukul S. Actitudes, conocimientos, y comportamientos de adolescentes de secundaria con respecto a la protección contra la exposición solar: un estudio en Bangkok, Tailandia. Photoderm Photoimm Photomed 2012;28:200–6.
19 Roren RS, Mario Christopher P, Novia Jayadi N. Conocimiento sobre fotoprotección y comportamiento fotoprotector de estudiantes universitarios: un estudio transversal en Indonesia. Revista Internacional de Dermatología y Venereología 2022;5:140–8.
20 Cheong KW, Yew YW, Seow WJ. Exposición al sol y seguridad solar. Hábitos entre adultos en Singapur: un estudio transversal. Ann Acad Med Singap 2019;48:412–28.
21 Hobbs C, Nahar VK, Ford MA, et al. Conocimientos, actitudes y comportamientos sobre el cáncer de piel en atletas universitarios. J Skin Cancer 2014;2014:248198.
22 Lee A, Garbutcheon-Singh KB, Dixit S, et al. La influencia de la edad y el género en el conocimiento, los comportamientos y las actitudes hacia la protección solar: un estudio transversal de pacientes australianos que acuden a clínicas ambulatorias. Am J Clin Dermatol 2015;16:47–54.
23 Gamba CS, Clarke CA, Keegan THM, et al. Supervivencia al melanoma Desventaja en hombres jóvenes blancos no hispanos en comparación con mujeres. JAMA Dermatol 2013;149:912–20.
24 Nguyen THT, Tran BX, Nguyen SH, et al. Actitudes y prácticas para la prevención del cáncer de piel entre pacientes con problemas dermatológicos en Hanoi, Vietnam: un estudio transversal. Salud Ambiental Prev Med 2020;25:35.
25 Parker G, Williams B, Driggers P. Conocimiento sobre la exposición al sol y Encuesta sobre las prácticas de los escuadrones de mantenimiento en la Base Aérea Travis. Mil Med 2015;180:26–31.
26 Kyprianou D, Charalambidou I, Famojuro O, et al. Conocimientos y actitudes de los chipriotas sobre la prevención del melanoma: ¿Existe un problema de salud pública? BMC Public Health 2022;22:53.
27 Cercato MC, Ramazzotti V, Sperduti I, et al. Protección solar entre los bañistas españoles: conocimientos, actitudes y comportamiento. J Cancer Educ 2015;30:4–11.
28 Savoye I, Olsen CM, Whiteman DC, et al. Patrones de radiación ultravioleta Exposición a la radiación y riesgo de cáncer de piel: el estudio E3N-SunExp. J Epidemiol 2018;28:27–33.
29 Koh D, Wang H, Lee J, et al. Carcinoma basocelular, carcinoma espinocelular y melanoma de la piel: análisis de los datos del Registro de Cáncer de Singapur 1968-97. Br J Dermatol 2003;148:1161–6.
30 Bradford PT. Cáncer de piel en piel de color. Dermatol Nurs 2009;21:170–7.
31 Shao K, Feng H. Disparidades raciales y étnicas en la atención médica del cáncer de piel en los Estados Unidos: una revisión de las desigualdades existentes, los factores contribuyentes y las posibles soluciones. J Clin Aesthet Dermatol 2022;15:16–22.
32 Jungers EA, Guenthner ST, Farmer ER, et al. Una iniciativa de educación sobre el cáncer de piel en un partido de béisbol profesional y resultados de una encuesta sobre cáncer de piel. Int J Dermatol 2003;42:524–9.
33 Gupta AK, Bharadwaj M, Mehrotra R. Preocupaciones sobre el cáncer de piel en Personas de color: factores de riesgo y prevención. Asian Pac J Cancer Prev 2016;17:5257–64.